



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN NEONATOLOGI
TAHUN 2024**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

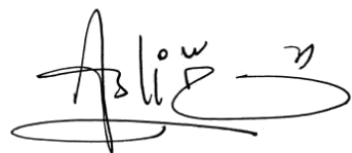
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 698/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024

Tentang
Pedoman Pelayanan Neonatologi

Disusun oleh :
Kepala Ruang Neonatologi

(Ayu Mayang Priningtiyas, S. Kep, Ns.)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS)

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 698/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN NEONATOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan yang efektif dan efisien bagi pasien Neonatologi di rumah sakit
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Neonatologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 586/RSPHS/I-KEP/DIR/V/2024 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN PELAYANAN NEONATOLOGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kriteria yang ditetapkan untuk masuk rawat di pelayanan Neonatologi.
- (2) Unit Neonatologi menerima rujukan pasien dari rumah sakit lain sesuai dengan standar dan fasilitas yang dimiliki dan bila pasien memerlukan perawatan intensif yang lebih tinggi tingkatannya dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai dengan kondisi pasien.

Pasal 2

- (1) Kriteria dokter Neonatologi adalah telah mengikuti pelatihan / pendidikan perawatan anak dan telah mendapat sertifikat melalui

- program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh perhimpunan profesi yang terkait.
- (2) Staf yang ada di Neonatologi adalah staf yang berkompeten dan terlatih.

Pasal 3

- (1) Indikasi pemeriksaan laboratorium dan radiologi berdasarkan permintaan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau dokter konsulen lain berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab Neonatologi.
- (2) Setiap permintaan laboratorium dan radiologi diinput oleh staf untuk selanjutnya di informasikan pada bagian terkait.

BAB II

KRITERIA KELUAR MASUK NEONATOLOGI

Pasal 4

- (1) Staf yang kompeten dan berwenang dari unit Neonatologi terlibat dalam menentukan kriteria.
- (2) Pasien yang membutuhkan perawatan di Unit Neonatologi dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan serta memberikan persetujuan untuk dirawat di Neonatologi.

BAB III

STANDART PELAYANAN I

Pasal 5

- (1) Pengaturan Standar Pelayanan Unit Neonatologi bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan unit Neonatologi
 - b. Memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang tepat.
 - c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.
 - d. Memberikan pelayanan informasi Kesehatan dengan tepat pada pasien dan keluarga sehingga dapat memenuhi hak pasien dan keluarga.

Pasal 6

- (1) Standar Pelayanan Unit Neonatologi meliputi :
 - a. Admisi meliputi pendaftaran pasien dilakukan secara langsung.
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostic meliputi laboratorium dan radiologi.
 - c. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis dengan asesmen awal DPJP dilakukan pada saat DPJP pertama kali kontak dengan pasien meliputi kondisi, diagnosis dan lokasi terindikasi tinggi jatuh berdasarkan indentifikasi
 - d. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan.
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter Spesialis.
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - g. Tindakan medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif.
 - h. Pemberian obat - obatan pada pasien sesuai dengan catatan daftar obat pasien dan instruksi dokter spesialis.
 - i. Pelayanan transfusi darah.
 - j. Pemberian surat rujukan.
 - k. Pemakaian peralatan yang tersedia

Pasal 7

- (1) Unit Neonatologi ikut serta dalam proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien bersama Panitia Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- (2) Setiap insiden yang terjadi pada pasien harus membuat laporan Insiden Keselamatan Pasien.

Pasal 8

- (1) Penundaan dan keterlambatan pelayanan di rawat inap harus disampaikan kepada pasien.
- (2) Semua pasien diberitahu alasan penundaan dan keterlambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternative yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dan dicatat di Rekam Medis.

Pasal 9

- (1) Dilakukan rencana pemulangan pasien (*Discharge Planning*) bagi pasien yang rencana pemulangannya kompleks dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.
- (2) *Discharge Planning* dilakukan secara terintegrasi antar PPA terkait dan difasilitasi manager pelayanan pasien (MPP).

Pasal 10

- (1) Semua pasien rawat inap ditentukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab mengelola pasien sesuai dengan kewenangan klinisnya serta melakukan koordinasi dan kesinambungan asuhan.
 - a. DPJP yang ditunjuk harus tercatat namanya di rekam medis.
 - b. DPJP memberikan keseluruhan asuhan selama pasien di Rumah Sakit dan berkolaborasi serta komunikasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya.

BAB IV RUJUKAN KELUAR

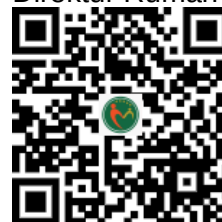
Pasal 11

- (1) Rumah Sakit memiliki staf terlatih yang mengelola rujukan.
- (2) Rumah Sakit bekerja sama dengan Rumah Sakit rujukan.
- (3) Rumah Sakit melakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Rujukan.

BAB V PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Juni 2024
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono., M.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga berhasil menyusun buku Pedoman Pelayanan Unit Neonatologi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Dunia perumasakitan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kebijakan pemerintah pada sektor kesehatan pada saat ini juga semakin baik, terutama kebijakan bahwa seluruh rumah sakit harus terakreditasi dengan seluruh layanan harus berfokus pada pasien. Oleh karenanya Rumah sakit dituntut untuk meningkatkan mutu layanan untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Dengan banyaknya pelayanan rumah sakit yang ada sekarang ini dan berkembangnya pelayanan Kesehatan saat ini serta semakin banyaknya pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat, diperlukan suatu peningkatan pelayanan kesehatan agar dapat bersaing dalam memebrikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, Unit Perinatologi merupakan salah satu bagian pelayanan Kesehatan yang harus bisa memberikan tindakan medis yang aman, efektif dengan memberdayakan sumber daya manusia yang kompetemm dan professional dalam menggunakan peralatan, obat – obatan yang sesuai dengan standar pelayana yang ada. Kesehatan Buku Pedoman Pelayanan Unit Perinatologi ini sangat penting bagi petugas yang bekerja di Rumah sakit karena sebagai acuan / pedoman dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepada pasien.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Untuk itu kami harapkan masukan bagi penyempurnaan buku ini dikemudian hari. Panduan ini tersusun atas kerja sama seluruh civitas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu tim penyusun mengucapkan terimakasih dan harapan kami semoga buku ini dapat dipergunakan dengan baik

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Juni 2024
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PELAYANAN NEONATOLOGI

PENGARAH

1. dr. Setya Budi Pamungkas, Sp. OG

Pelaksana

1. dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS
2. dr. Mohmmad Helmi Wibisono
3. dr. Doddy Adi Nugroho
4. dr. Achmad Fauzan Ailani
5. dr. Tania Calista
6. dr. Khairul Wafa Musthofa
7. dr. Naufal Najmuddin
8. dr. Fina Jazila Rizqiyah
9. dr. Nejowa Ermaq Fatreciano
10. dr. Novita Oktaviana
11. dr. Cyntia Mustika Anggraeini
12. dr. Adni Kautsari Ismini
13. dr. Reka Vikaria Anggreli
14. dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG
15. dr. Mulyo Hadi Wibiwo, Sp. OG
16. dr. Rudy Priyo Utomo, Sp. OG
17. dr. Esty Purwaningrum, Sp. A
18. dr. Muhammad Irawan, Sp. A
19. dr. Ratih Kusumawardani, Sp. A., M. Biomed
20. Angela Wensi Flora Rosa, S. Kep. Ns
21. Mohammad Lukman Hakim I, S. Kep. Ns
22. Hendi Wijayanto, S. Kep. Ns
23. Anis Purnamasari, AMd. Kep
24. Bagas Suryo Purwono, AMd. Kep
25. Siti Maysaroh, AMd. Kep
26. A. Kharimulloh I, S. Kep. Ns
27. Debi Firmanasia, AMd. Kep
28. Ninis Indrawati, Str. Keb
29. Ayu Mayang Priningtyas, S. Kep. Ns
30. Dwi Siska Hardiyanti, S. Kep. Ns
31. Nuri Aini Izzah, S. Kep, Ns
32. Sisca Puspitasari, S. Kep, Ns
33. Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns, M. Kep
34. Dan seluruh staf di RS Prima Husada Sukorejo

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB 1 PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 3

 1.2 Tujuan Pedoman 4

 1.3 Ruang Lingkup Pelayanan 4

 1.4 Batasan Operasional 5

 1.5 Dasar Hukum 5

BAB II STANDART KETENAGAAN

 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 8

 2.3 Distribusi Ketenagaan 8

 2.4 Pengaturan Jaga 8

BAB III STANDART FASILITAS

 3.1 Denah Ruangan 12

 3.2 Standart Fasilitas 12

 3.3 Persyaratan Khusus 12

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

 4.1 Kriteria Pasien Masuk Neonatologi 14

 4.2 Kriteria Pasien Keluar Neonatologi 14

 4.3 Admisi Pasien Neonatologi 14

 4.4 Jenis Pelayanan diruang Neonatologi 15

 4.5 Persiapan Penerimaan Pasien 16

 4.6 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan 16

 4.7 Pasien Pulang 16

 4.8 Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan 17

BAB V LOGISTIK

 5.1 Barang Tetap 18

 5.2 Barang Habis Pakai 19

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

 6.1 Pengertian 20

6.2 Tujuan	20
6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien	20
BAB VII KESELAMATAN KERJA	
7.1 Pengertian	22
7.2 Prinsip Dasar Usaha Keselamatan Kerja	22
7.3 Tujuan Keselamatan Kerja	22
7.4 Kapasitas Kerja dan Beban Kerja	23
7.5 Lingkungan Kerja dan Penyakit Kerja yang Ditimbulkannya	23
7.6 Klasifikasi Kecelakaan Kerja	23
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU	
8.1 Upaya Peningkatan Mutu Keperawatan	25
8.2 Monitoring dan Evaluasi Mutu Keperawatan	26
BAB IX PENUTUP	
LAMPIRAN	

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 698/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN NEONATOLOGI**

PEDOMAN PELAYANAN NEONATOLOGI

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan banyaknya pelayanan Rumah sakit yang ada sekarang ini dan berkembangnya pelayanan kesehatan saat ini serta semakin banyaknya pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat, diperlukan suatu peningkatan pelayanan kesehatan agar dapat bersaing dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, Instalasi Neonatologi merupakan salah satu bagian pelayanan kesehatan yang harus bisa memberikan tindakan medis yang aman, efektif dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dalam menggunakan peralatan, obat-obatan yang sesuai dengan standar terapi di Indonesia

Pelayanan di Instalasi Neonatologi meliputi :
Perawatan BBLR , ikterus, bayi dengan masalah minum/muntah, bayi yang lahir dengan infeksi intra uterin, bayi yang lahir dengan tindakan vakum ekstraksi, forceps ekstraksi, Sectio Caesarea dan bayi dengan kelahiran sungsang yang bermasalah/sulit.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan tersebut di atas, maka disusunlah pedoman pelayanan Instalasi Neonatologi. Pedoman ini adalah pedoman minimal dan dapat dikembangkan kapanpun seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud
Maksud disusunnya Pedoman Pelayanan Neonatologi adalah untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh staf Neonatologi.
- 2. Tujuan Umum
Tujuan meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Neonatologi
- 3. Tujuan Khusus
 - a. Memiliki standar ketenagaan di Instalasi Neonatologi
 - b. Memiliki standar fasilitas di Instalasi Neonatologi
 - c. Memiliki tata laksana di Instalasi Neonatologi
 - d. Memiliki standar logistik di Instalasi Neonatologi
 - e. Memiliki standar keselamatan pasien di Instalasi Neonatologi
 - f. Memiliki standar keselamatan kerja di Instalasi Neonatologi
 - g. Memiliki standar pengendalian mutu di Instalasi Neonatologi

1.3. SASARAN

Pelaksana pedoman ini adalah para tenaga kesehatan (Perawat Neonatologi)

1.4. RUANG LINGKUP

Pelayanan dan asuhan untuk kasus perinatologi diberikan pada bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari.

1.5. PENGERTIAN

Pelayanan neonatologi adalah suatu pelayanan yang digunakan untuk menunjang Kesehatan bayi baru lahir yang diberikan secara adekuat meliputi: pencegahan hipotermi,perawatan tali pusat,IMD,asi eksklusif,pencegahan infeksi,pemberian imunisasi dan deteksi dini tanda bahaya dengan melakukan pemeriksaan fisik

1.6. BATASAN OPERASIONAL

Tingkat pelayanan kesehatan neonatus terbagi dalam 3 (tiga) level, yaitu:

- a. Level I,
- b. Level II, yang terbagi dalam level II A dan II B, dan
- c. Level III.

Instalasi perinatologi RS Prima Husada Sukorejo melakukan pelayanan pada level I dan II A dengan batasan operasional sebagai berikut:

Tingkat pelayanan	Fungsi Unit	Kriteria Rawat
Level I	• Resusitasi neonatus • Rawat gabung bayi sehat – ibu • Asuhan evaluasi pasca lahir neonatus sehat • Stabilisasi dan pemberian asuhan bayi baru lahir usia kehamilan 35-37 minggu yang stabil secara fisiologis • Perawatan neonatus usia kehamilan < 35 minggu atau neonatus sakit sampai dapat pindah ke fasilitas asuhan neonatal spesialistik.	• Neonatus normal, stabil, cukup bulan dengan berat lahir ≥ 2500 gram • Neonatus hampir cukup bulan (masa kehamilan 35-37 minggu), stabil secara fisiologis, bayi dengan risiko rendah • Neonatus dengan observasi ≤6 jam dalam kondisi stabil • Bayi dengan BB ≤2500 gram (masa kehamilan aterm) dalam kondisi stabil
Tingkat pelayanan	Fungsi Unit	Kriteria Rawat
Level II A	• Resusitasi dan stabilisasi bayi prematur dan atau sakit sebelum pindah ke fasilitas asuhan intensif neonatus • Pelayanan bayi yang lahir dengan usia kehamilan > 32 minggu dan berat lahir > 1500 gram yang memiliki ketidak mampuan fisiologis seperti: apnea, prematur, tidak mampu menerima asupan oral, menderita sakit yang tidak diantisipasi sebelumnya dan membutuhkan pelayanan sub spesialistik dalam waktu mendesak • Oksigen nasal dengan pemantau saturasi oksigen	• Bayi prematur > 32 minggu • Bayi dari ibu dengan diabetes • Bayi yang lahir dari kehamilan beresiko tinggi atau persalinan dengan komplikasi • Gawat nafas yang tidak memerlukan bantuan ventilasi • BBLR > 1500 gram • Hiperbilirubinemia yang perlu terapi sinar • Sepsis neonatorum • Hipotermia • Upper GI bleeding • Vomiting of new born • Bayi BBLR tanpa distres nafas

	● Infus intravena perifer dan nutrisi parenteral untuk jangka waktu terbatas. ● Memberikan asuhan bayi dalam masa penyembuhan pasca perawatan intensif	
Level II B	● Resusitasi dan stabilisasi bayi prematur dan atau sakit sebelum pindah ke fasilitas asuhan intensif neonatus ● Pelayanan bayi yang lahir dengan usia kehamilan > 32 minggu dan berat lahir > 1500 gram yang memiliki ketidakmampuan fisiologis seperti: apnea, prematur, tidak mampu menerima asupan oral, menderita sakit yang tidak diantisipasi sebelumnya dan membutuhkan pelayanan sub spesialisik dalam waktu mendesak ● Oksigen nasal dengan pemantau saturasi oksigen ● Infus intravena perifer dan nutrisi parenteral untuk jangka waktu terbatas. ● Memberikan asuhan bayi dalam masa penyembuhan pasca perawatan intensif	● Gawat nafas yang memerlukan bantuan ventilasi mekanik ≤24 jam (tekanan jalan nafas positif terus menerus)

Kriteria rujuk :

- a. Bayi dengan gangguan hemodinamik.
- b. Apnea
- c. Gawat nafas sedang atau parah, memerlukan CPAP atau ventilasi jangka pendek selama < 7 hari
- d. BBLSR < 1500 gram
- e. Bayi dengan hasil pemeriksaan neurologis abnormal
- f. Bayi dengan kejang
- g. Bayi yang perlu transfusi tukar untuk hiperbilirubinemia atau polisitemia
- h. Nutrisi parenteral total untuk < 7 hari

1.7. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan pedoman Instalasi Perinatologi adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 340/Menkes/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

-
7. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
 8. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 604 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan kelas D
 11. Pedoman Uraian Tugas Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2001
 12. Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2001.
 13. Standar Peralatan Keperawatan Dan Kebidanan Di Sarana Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2001.
 14. Standar Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2005.
 15. Pedoman Perancangan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2005.
 16. Pedoman Pelayanan Rawat Gabung di RS, Departemen Kesehatan 1991
 17. Pedoman Pelayanan Perinatal Pada Rumah Sakit Umum kelas C Dan D Departemen Kesehatan 1991.
 18. Panduan Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir Untuk Dokter, Bidan Dan Perawat Di RS, Departemen Kesehatan – IDAI 2004.
 19. Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B (non pendidikan), C dan D, Departemen Kesehatan 2006.

BAB II
STANDART KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi sumber daya manusia di Instalasi Neonatologi adalah :

1. SMF Anak (2 orang)
 - a. Pendidikan Spesialis Anak
 - a. Pelatihan pelayanan Lanjut Neonatus untuk spesialis
 - b. Pelatihan pelayanan Dasar Neonatus
2. Kepala Ruangan (1 orang)
 - a. Pendidikan D III Keperawatan dengan masa kerja minimal 5 tahun
 - b. Pendidikan S1 Keperawatan dengan masa kerja minimal 2 tahun
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan Manajemen Bangsal dan Pelatihan perinatalogi
 - d. Memiliki sertifikat Resusitasi Neonatus
 - e. Memiliki kompetensi yang baik dalam menegakkan diagnose keperawatan, maupun mengambil keputusan klinis dan terampil dalam melakukan tindakan Keperawatan
 - f. Pengalaman bekerja sebagai pelaksana minimal 5 tahun
3. Pelaksana (4 orang)
 - a. Pendidikan minimal DIII/S1 Keperawatan dengan masa kerja minimal 2 tahun
 - b. Sertifikat minimal Kegawat daruratan Neonatus, Teknik Resusitasi Neonatus dan Manajemen Laktasi
 - c. Bersedia bekerja dengan sistem shift
 - d. Dapat melakukan bantuan hidup dasar

Kemampuan setara dengan tingkat pelayanan kesehatan neonatus:

Level I	Level II A
• Perawat dan dokter harus terlatih dalam asuhan neonatal (ASI, resusitasi neonatus, kegawat daruratan neonatus) • Rasio perawat : pasien = 1: 6-8 • Ahli manajemen laktasi yang dapat dihubungi 24 jam	• Dokter spesialis anak yang telah mengikuti pelatihan khusus neonatologi, harus bersedia 24 jam • Ahli manajemen laktasi untuk setiap tugas jaga • Rasio perawat : pasien 1 : 2-4 dalam setiap tugas jaga

2.2 Distribusi Ketenagaan

1.1 Distribusi Ketenagaan di Ruang Neonatologi adalah :

- 2.2.1 Dokter Spesialis Anak
- 2.2.2 Seorang dokter umum sebagai dokter jaga ruangan perawatan dalam satu shift
- 2.2.3 Satu perawat untuk 2-3 tempat tidur/pasien dalam satu shift

2.3Pengaturan Jaga

1.2 Pengaturan Jaga di Ruang Neonatologi adalah sebagai berikut :

1. Tenaga medis :
 - a. Dokter Spesialis Anak berjaga secara on call
 - b. Dokter Umum berjaga secara on site, dalam 24 jam terbagi menjadi 3 waktu dinas, yaitu Dinas Pagi, Sore dan Malam. Dokter Umum merangkap sebagai dokter IGD dan dokter jaga ruangan.
2. Tenaga Perawat/Bidan
 - a. Terdiri dari Bidan dan Perawat di ruangan yang berjaga secara on site, dalam 24 jam terbagi menjadi 3 waktu dinas, yaitu Dinas Pagi, Sore dan Malam.

-
- b. Pembagian waktu jam dinas yaitu
 - 1) Dinas Pagi dari jam 06.30 - 14.00
 - 2) Dinas Sore dari jam 14.00 - 21.00
 - 3) Dinas Malam dari jam 21.00 - 07.00
 - c. Pengaturan jadwal dinas Perawat di ruangan dilakukan oleh Kepala Ruangan
 - d. Apabila ada pegawai yang mengalami sakit atau ada anggota keluarga yang meninggal, serta musibah maka penjadwalan dinas diatur kembali oleh Kepala ruangan, dan tidak ada penggantian dinas.

BAB III
STANDART FASILITAS

3.1 Denah Ruangan
Terlampir

3.2 Standart Fasilitas

NO	NAMA RUANGAN	FUNGSI	BESAR RUANG/LUAS	KEBUTUHAN FASILITAS
1	Ruang Perawatan Neonatologi	Ruangan untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam	Ukuran ruangan minimal 6m x 8m	Inkubator, bok bayi, Infant radiant warmer, meja tindakan, CPAP, Suction, Resusitasi kit
2	Ruang Stasi Perawat (Nurse Station)	Ruang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian asuhan dan pelayanan keperawatan (pre dan postconference, pengatur jadwal), dokumentasi sampai dngan evaluasi pasien	3-4 m2/perawat (Ket:perhitungan 1 stase perawat untuk melayani maksimum 20 tempat tidur)	Meja, Kursi, lemari arsip, lemari obat, telepon/intercom alat minitoring untuk pemantauan terus menerus fungsi-fungsi vital pasien
3	Ruang Linen Bersih	Tempat penyimpanan bahan-bahan linen steril/bersih	Min. 4 m2	Lemari
4	KM/WC (petugas)	KM/WC	KM/WC Pria/wanita luas 2 m ² - 3 m ²	Kloset, wastafel, bak air

3.3 Persyaratan Khusus

Perletakan ruangnya secara keseluruhan perlu adanya hubungan antar ruang dengan skala prioritas yang diharuskan dekat dan sangat berhubungan/membutuhkan.

1. Kecepatan bergerak merupakan salah satu kunci keberhasilan perancangan, sehingga blok unit sebaiknya sirkulasinya dibuat secara linen/lurus (memanjang). Konsep Rawat Inap yang disarankan “Rawat Inap Terpadu (Integrated Care)” untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang.
2. Bangunan Ruang Rawat Inap harus terletak pada tempat yang tenang (tidak bising), aman dan nyaman tetapi tetap memiliki kemudahan aksesibilitas dari sarana penunjang rawat inap.
3. Alur petugas dan pengunjung dipisah.
4. Lantai harus kuat dan rata tidak berongga, bahan penutup lantai, mudah dibersihkan, bahan tidak mudah terbakar.
5. Pertemuan dinding dengan lantai disarankan berbentuk lengkung agar memudahkan pembersih dan tidak menjadi tempat sarang debu/kotoran.
6. Plafon harus rapat dan kuat, tidak rontok dan tidak menghasilkan debu/kotoran

lain

7. Khusus untuk pasien-pasien tertentu harus dipisahkan seperti:
 - a. Pasien yang menderita penyakit menular
 - b. Pasien dengan pengobatan yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, ganggren, diabetes, dsb)
8. Nurse Station perawat harus terletak di pusat blok yang dilayani agar perawat dapat mengawasi pasiennya secara efektif, maksimum melayani 20 tempat tidur.
9. Adanya CCTV yang aktif 24 jam guna untuk menjaga keselamatan bayi atau menghindari adanya menculikan bayi atau kejadian bayi tertukar.

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Kriteria Pasien Masuk Neonatologi

1. Bayi sakit atau bayi baru lahir dengan umur bayi 0 – 28 hari dengan berat badan bayi < 2500 gram dan > 4000 gram yang tidak memiliki ketidak matangan fisiologis seperti apnoe, prematuritas, ketidak mampuan dalam asupan oral atau menderitn sakit yang tidak diantisipasi sebelumnya.
2. Umur sampai dengan 28 hari dengan berat badan kurang dari 4000 gram
3. Bayi lahir cukup bulan yang mempunyai masalah / kelainan penyerta
4. Bayi lahir kurang bulan (Premature)
5. Post resusitasi lama (sampai tahap VTP) dan memerlukan monitoring
6. Bayi yang memerlukan infus intra vena perifer dan mungkin nutrisi parenteral untuk jangka waktu terbatas.
7. Level II adalah kondisi gangguan hemodinamik ringan yang membutuhkan pemantauan hemodinamik dengan Kriteria Fisiologi pernafasan > 60x/menit, Nadi 140 -160 x/menit, kecukupan oksigen dalam darah dibawah 88%.
8. Asfiksia sedang dengan kriteria fisiologis frekuensi nafas 60 – 80 x/menit, retraksi ringan, sianosis, merintih yang memerlukan alat non invasif (NCPAP).
9. Icteric Neonatorum yang perlu terapi fototerapi dan terapi cairan dengan hasil bilirubin bayi > 16 mg/dl

4.2 Kriteria Pasien Keluar Neonatologi

1. Bayi telah menunjukkan tanda vital stabil di boks terbuka selama 24-48 jam. Normalnya, suhu tubuh bayi 36,5⁰ C-37,5⁰ C, frekuensi pernapasan 30-40 x/mt, nadi 120-160 x/mt.
2. Keberhasilan menyusui sudah mulai tercapai
3. Penambahan berat badan dengan pemberian asupan per oral telah terlihat
4. Semua obat yang diperlukan dapat diberikan per oral
5. Nilai laboratorium telah normal
6. Tingkat aktivitas normal telah tercapai
7. Ibu dan ayah memperlihatkan kemampuan untuk mengasuh neonatus

4.3 Admisi Pasien Neonatologi

1. Bayi Neonatus yang lahir di RS Prima Husada Sukorejo

Dari ruang VK atau OK bayi dibawa ke ruang BBL untuk resusitasi, dilakukan pemberian injeksi Vit. K sebanyak 1 mg secara IM pada paha kiri, serta dilakukan pemberian salep mata pada kedua mata bayi, kemudian dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi yang lahir spontan atau SC dan keadaan umum baik, memakai gelang identitas, dan kemudian dibawa ke ruang bayi oleh perawat ruang bayi. Dilakukan evaluasi minimal 6 jam diruang bayi, jika bayi dengan keadaan umum baik dilakukan rawat gabung dengan ibu.

Untuk bayi dengan keadaan umum kurang baik, setelah dilakukan resusitasi hingga stabil dibawa ke ruang perinatologi oleh perawat ruang bayi. Perawat ruang bayi menelpon ke bagian pendaftaran untuk mendaftarkan bayi dengan nama By.Ny.... dan memakaikan gelang identitas bayi sesuai identitas bayi.

2. Bayi neonatus yang masuk rawat dari poliklinik anak atau IGD

Pasien bayi neonatus yang masuk perinatologi sebelum masuk ruangan oleh tenaga keperawatan harus dilakukan serah terima pasien meliputi:

1. Identitas pasien
Identitas pasien merupakan hal yang sangat penting ditanyakan kepada petugas yang mengoperkan dan mengklarifikasi kebenarannya kepada pasien dan keluarga pasien itu sendiri, dengan tujuan memperoleh data awal dan sudah terjalin komunikasi antara petugas dan pasien.
2. General consent
General consent perlu dilihat dalam status pasien dan ditanyakan kepada petugas atas kelengkapan general consent, yaitu terdapat tanda tangan keluarga pasien sebagai penanggungjawaban serta bersedia dengan peraturan serta pelayanan yang akan diberikan.
General consent perlu juga di klarifikasi kepada pasien atau keluarga pasien atas penandatanganan yang sudah dilakukan oleh keluarga pasien
3. Kelanjutan therapy
Kelanjutan therapy yang harus kita perhatikan adalah therapy yang sudah diberikan dan therapy apa saja yang akan dilakukan pada saat operan dilakukan sehingga tidak memperburuk kondisi pasien saat masuk ruangan perinatologi.
4. Edukasi kepada orang tua yang sudah dilakukan
Tindakan edukasi dapat dilihat dalam status pasien atas edukasi yang sudah dilakukan oleh petugas sebelumnya dan dapat diklarifikasi kembali kepada petugas yang mengoperkannya. Dengan tujuan agar petugas dapat merencanakan kegiatan edukasi yang sifatnya pasien atau keluarga memahaminya
5. Orientasi
Staf yang bertugas di anjurkan mengorientasikan keluarga pasien dengan menjelaskan tempat-tempat pasien yang mesti diketahui dalam rangka kebutuhan dasar pasien selama dirawat, terapi yang diberikan, dan alat yang terpasang pada pasien.

4.4 Jenis Pelayanan di ruang Neonatologi

1. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis.
2. Perawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan secara berkala.
3. Edukasi keluarga pasien oleh perawat dan TIM kesehatan lain.
4. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan.
5. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
6. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
7. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik dan terapeutik.
8. Pemberian obat-obatan pada pasien sesuai dengan catatan daftar obat pasien dan instruksi dokter spesialis.
9. Pelayanan Tranfusi Darah.

4.5 Persiapan Penerimaan Pasien

1. Flowsheet
2. Timbangan bayi
3. Tempat tidur bayi
4. Phototerapi
5. Infus pump/ Syringe Pump
6. Infant Warmer/ Inkubator
7. Monitor (Nadi, Saturasi Oksigen, Pernafasan)
8. O2 Central (peralatan pemberian Oksigen : Oxyhood, kateter nasal)
9. Suction
10. Termometer
11. Ambubag

4.6 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan

1. Obserasi keadaan umum pasien tiap 2 jam
2. Observasi tanda – tanda vital tiap 2 jam
3. Pengukuran intake dan output asien tiap 3-4 jam
4. Merubah posisi 2 – 3 jam sekali.

4.7 Pasien Pulang

1. Resume Pasien Pulang
 - a. Pasien pulang diperoleh setelah hasil evaluasi dokter tindakan terapi diberhentikan dan perbolehkan pulang
 - b. Lakukan resume pasien sebagai bahan untuk kontrol dan keperluan riwayat penyakit dalam pertimbangan terapi yang akan datang
2. Rencana tindak lanjut
Rencana tindak lanjut lakukan edukasi asuhan perawatan dirumah yang berhubungan dengan asuhan:
 - a. Perawatan tali pusat
 - b. Perawatan menjemur bayi
 - c. Edukasi laktasi
 - d. Pemberian obat
 - e. Memandikan bayi
 - f. Asuhan yang bersifat khusus bagi pasien dengan kasus khusus
3. Pasien Meninggal
 - a. Bila pasien meninggal lakukan asuhan jenazah di ruangan neonatologi
 - 1) Buka semua peralatan yang menempel di pasien
 - 2) Buka baju pasien
 - 3) Ikat tangan pasien tangan kanan memegang tangan kiri
 - 4) Tutup dengan laken
 - 5) Tunggu 2 jam
 - 6) Informasikan kebagian ambulan dan jenazah
 - b. Pasien dirujuk
Pasien dirujuk bila atas indikasi tidak dapat dilakukan di rumah sakit dikarenakan sarana tidak lengkap, permintaan sendiri dari pasien adapun persiapan yang harus dilakukan
 - 1) Lakukan komunikasi dengan tempat yang akan menerima rujukan (lihat Panduan Transfer Pasien)
 - 2) Bila sudah tersedia ruangan maka hubungi ambulan
 - 3) Setelah siap ambulan kondisikan tim yang akan merujuk sesuai dengan kondisi pasien (lihat pada panduan transfer pasien)
 - 4) Transportasi pasien menggunakan inkubator

4.8 Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan

1. Laporan Harian
Laporan harian dibuat untuk seluruh pasien perina, laporan ini terdiri dari laporan 3 shift yaitu pagi, siang dan malam yang dilakukan saling berkesinambungan isi dari laporan tersebut adalah:
 - a) Identitas pasien
 - b) Observasi tanda – tanda vital
 - c) Cairan yang didapat pasien, dan jumlah cairan yang keluar dan masuk.
 - d) Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien setiap harinya
 - e) Obat-obatan yang didapat pasien dan alat – alat yang terpasang pada pasien

-
2. Laporan bulanan
Laporan kepala ruang kepada manajer keperawatan
 3. Laporan 3 bulan
Laporan kegiatan PERISTI terhadap manajer keperawatan, laporan ini berisi tentang :
 - a. Jumlah bayi yang dirawat pada perawatan level I,II,III
 - b. Jumlah ibu yang melahirkan
 - c. Jumlah ibu yang meninggal
 - d. Jumlah bayi yang lahir hidup
 - e. Jumlah bayi yang meninggal
 - f. Jumlah bayi yang berat badan lahirnya kurang dari 2500 gram
 - g. Jumlah IUFD

BAB V

LOGISTIK

Kebutuhan barang-barang logistik di Instalasi Perinatologi terdiri dari barang tetap dan barang habis pakai. Barang tetap terdiri dari peralatan medis, peralatan keperawatan, alat tenun dan peralatan rumah tangga. Sedangkan barang habis pakai terdiri dari : Obat-obatan dan bahan habis pakai alkes (BHP), alat kebersihan, Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK). Untuk proses pengadaan barang habis pakai di tiap ruangan melalui 3 proses, yaitu :

1. Perencanaan
Kepala Ruangan mendata kebutuhan barang (BHP, alat kebersihan, cetakan dan ATK) dalam 1 tahun dan membuat rencana kebutuhan berdasar pemakaian tahun lalu ditambah 10%
2. Permintaan
3. Permintaan kebutuhan barang perbulan ruangan dilakukan setiap awal bulan sesuai jadwal ke bagian farmasi untuk BHP, dan ke bagian penyimpanan barang untuk alat kebersihan, cetakan dan ATK
4. Penyimpanan
5. Penyimpanan barang dilakukan di tiap ruangan selama 1 bulan

5.1 Barang Tetap

1. Peralatan Keperawatan
 - a. Ruang Rawat Inap Neonatologi
 - 1) Inkubator
 - 2) Baby scale
 - 3) Neonatal transport incubator
 - 4) Cuvis
 - 5) Box Bayi
 - 6) Infant warmer
 - 7) Infusion pump
 - 8) Suction
 - 9) Standar infuse
 - 10) Bag mask neonatus
 - 11) Termometer digital
 - 12) Phototerapi
 - 13) Humidifier
 - 14) Pulse oximetri
 - 15) CPAP
 - 16) Stetoskop bayi
2. Alat Tenun
 - a. Selimut bayi
 - b. Sprey infant warmer
 - c. Sprei bayi
 - d. Sarung bantal bayi
3. Peralatan Rumah Tangga
 - a. Lemari
 - b. Kulkas
 - c. Bak mandi Bayi
 - d. Tempat sampah
 - e. Jam dinding
 - f. Meja Perawat
 - g. Dispenser
 - h. Kursi Perawat
 - i. Troli Tindakan

-
- j. 1 Unit Komputer
 - k. 1 Unit Telepone
 - l. 3 Unit AC
 - m. 2 Unit Kipas Angin

5.2 Barang Habis Pakai

1. Obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP)
 - a. Tiap ruangan dalam Instalasi Neonatologi memiliki persediaan obat dan bahan habis pakai yang berasal dari bagian farmasi untuk keadaan kegawat daruratan sesuai dengan standar therapy
 - b. Pemakaian obat pasien dilakukan dengan cara meresepkan obat sesuai kebutuhan dan disimpan dalam loker obat pasien selama pasien dirawat di ruangan rawat inap.
2. Alat kebersihan
Regulasi sesuai dengan kebutuhan di ruangan
3. Alat tulis kantor
Regulasi sesuai dengan kebutuhan ruangan

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN

6.1 Pengertian

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka upaya pelaksanaan keselamatan pasien di RS perlu dilakukan. Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan RS terutama di dalam melaksanakan keselamatan pasien sangat diperlukan suatu pedoman yang jelas sehingga angka kejadian KTD dapat dicegah sedini mungkin.

6.2 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit.
4. Terlaksananya program – program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien

1. Keselamatan pasien merupakan hal yang terutama dalam pelayanan keperawatan.
2. Terdapat perawat yang memahami mengenai keselamatan pasien.
3. Terdapat sistem pelayanan yang komprehensif, baik medis maupun keperawatan sehingga meminimalkan terjadinya kasus yang tidak diharapkan (KTD).
4. Identifikasi pasien harus dilakukan secara lengkap, baik berupa status maupun gelang identitas.
5. Sarana dan prasarana harus mengindahkan keselamatan pasien : sterilitas alat, tabung oksigen, tempat tidur dorong, privacy, dll.
6. Sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien petugas melakukan kebersihan tangan procedural perina.
7. Terdapat evaluasi berkala kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Terdapat pelaporan kasus yang tidak diharapkan, yaitu :
 - a. Insidens kesalahan identifikasi kedaruratan pasien.
 - b. Insidens pasien jatuh.
 - c. Insidens kejadian infus blong.
 - d. Insidens kesalahan pemberian obat.
 - e. Insidens kesalahan cara pemberian obat.
 - f. Insidens kesalahan persiapan pemeriksaan penunjang
9. Membangun kesadaran atau budaya akan nilai keselamatan pasien

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

7.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang berada di rumah sakit termasuk instalasi farmasi dengan demikian keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di rumah sakit serta masyarakat di sekitar rumah sakit yang mungkin terkena dampak akibat suatu proses kerja. Dengan demikian jelas bahwa keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka/cidera, cacat/ kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan mesin dan lingkungan secara luas.

Dalam menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Instalasi Neonatologi disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit, dengan selalu berkoordinasi dengan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS Prima Husada Sukorejo dan unit terkait lainnya.

7.2 Prinsip Dasar Usaha Kesehatan Kerja

Prinsip dasar usaha kesehatan kerja terdiri atas : Ruang lingkup usaha kesehatan kerja. Kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyesuaian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya baik fisik maupun psikis dalam hal cara / metode kerja dan kondisi yang bertujuan untuk :

- 1) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosial.
- 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan / kondisi lingkungan kerjanya.
- 3) Memberikan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja didalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.
- 4) Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan.

7.3 Tujuan Keselamatan Kerja

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan ketika melakukan pekerjaan
2. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya paparan dari zat kimia yang membahayakan
3. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis
4. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
5. Menerapkan ergonomi di tempat kerja
6. Mengamankan dan memelihara alat-alat perlengkapan farmasi
7. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
8. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
9. Mensesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

7.4 Kapasitas Kerja dan Beban Kerja

Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja merupakan tiga komponen utama dalam kesehatan kerja, dimana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan kerja yang optimal. Kapasitas kerja seperti status kesehatan kerja dan gizi kerja serta kemampuan fisik prima diperlukan agar

seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara optimal. Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja yang prima merupakan modal awal seseorang untuk mencapai produktifitas yang diharapkan. Kondisi awal seseorang untuk bekerja dapat dipengaruhi oleh kondisi temperatur kerja, gizi kerja, kebugaran jasmani dan kesehatan mental. Beban kerja meliputi fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja.

7.5 Lingkungan Kerja dan Penyakit Kerja yang Ditimbulkannya

Penyakit akibat kerja dan / atau berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh pemajanan di lingkungan kerja. Fakta di lapangan menunjukkan terdapat kesenjangan antara pengetahuan tentang bagaimana bahaya kesehatan berperan dan usaha untuk mencegahnya antara kognisi dan emosi. Misalnya alat pelindung kerja yang tidak digunakan secara tepat oleh pekerja rumah sakit dengan kemungkinan terpajan melalui kontak langsung atau tidak tersedianya pelindung. Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka langkah awal penting adalah pengenalan / identifikasi bahaya yang dapat ditimbulkan upaya perlindungan dan penanggulangan dan dievaluasi kemudian dilakukan pengendalian.

7.6 Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Klasifikasi kecelakaan kerja di Instalasi perinatologi secara garis besar, diantaranya :

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan
 - a. Terjatuh
 - b. Tersandung benda
 - c. Terbentur alat
 - d. Terkena arus listrik dll
2. Klasifikasi menurut agen penyebabnya
 - a. Alat-alat keperawatan seperti tertusuk jarum suntik, terbentur, dll
 - b. Lingkungan kerja, seperti ruangan panas, pencahayaan kurang.
3. Klasifikasi menurut jenis luka dan cideranya
 - a. Efek terkena zat kimia
 - b. Efek terkena menghirup obat
 - c. Patah tulang
 - d. Keseleo/dislokasi/terkilir
 - e. Kenyerian otot dan kejang
 - f. Luka tergores
4. Klasifikasi menurut lokasi bagian tubuh yang terluka
 - a. Kepala, leher, badan, lengan, kaki dan berbagai bagian tubuh lainnya
 - b. Luka umum dsb
5. Pencegahan kecelakaan kerja
Pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan instalasi Neonatologi diantaranya adalah :
 - a. Desain ruangan
Ruangan Neonatologi di desain dengan aturan yang berlaku.
 - b. Meja ners station
Selalu bersih dan tidak ada makanan.
 - c. Berhati-hati melakukan tindakan
 - d. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai indikasi
 - e. Sosialisasi SPO Praktek Menyuntik Aman dan SPO penggunaan APD

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

8.1 Upaya Peningkatan Mutu Keperawatan

Upaya untuk menjamin mutu pelayanan asuhan keperawatan di RS bidang keperawatan membuat Program Pengendalian dan Peningkatan Mutu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu tersebut.

Perumusan dan penyusunan kebijakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi melalui masukan dari seluruh jajaran dan staf keperawatan yang terlibat dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang keperawatan secara periodik yang kemudian ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada Direksi.

Kegiatan dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan, dapat dilakukan melalui :

1. **Audit Keperawatan**

Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien. Hal ini cukup penting karena kekurangan dalam pelayanan keperawatan dapat mengancam jiwa dan kehilangan nyawa klien.

Langkah-langkah dalam melaksanakan audit keperawatan

- a. Menentukan masalah tertentu untuk dipelajari dan diulas.
- b. Menentukan kriteria atau standar profesi yang jelas, obyektif dan rinci
- c. Mempelajari catatan keperawatan dan catatan medik
- d. Para perawat mempelajari kasus yang tidak memenuhi kriteria, dianalisis, didiskusikan kemungkinan penyebabnya.
- e. Membuat rekomendasi penanganan kasus yang tidak memenuhi kriteria.
- f. Membuka lagi topik yang sama di lain waktu, misalnya setelah 6 bulan kemudian, untuk menilai dan meyakinkan bahwa kelemahan/ kekurangan yang diidentifikasi telah diperbaiki dan tidak diulang kembali.
- g. Perlu dipastikan bahwa audit keperawatan ini bukan acara pengadilan dari kekurangan pelayanan yang ada tetapi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
- h. Audit keperawatan paling tidak dilakukan sebulan sekali membahas tentang pelaksanaan asuhan keperawatan/kebidanan di RSU.

2. **Ronde Keperawatan**

Merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilakukan oleh perawat dengan melibatkan pasien, perawat, kepala perawat dan seluruh anggota tim. Ronde Keperawatan minimal dilakukan 2x setahun di ruang perawatan rawat inap/rawat jalan.

3. **Survey Kepuasan Pasien.**

Suatu kegiatan untuk mendapatkan masukan dari pasien atau keluarga mengenai kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan melalui pengisian angket oleh pasien atau keluarga pasien.

8.2 Monitoring dan Evaluasi Mutu Keperawatan

Monitoring terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan oleh seluruh pengelola keperawatan termasuk kepala perawat di unit pelayanan masing-masing. Upaya perbaikan yang berkaitan dengan mutu keperawatan akan dilakukan secara terus menerus di unit pelayanan. Sedangkan evaluasi akan dilakukan setahun sekali oleh Manager Keperawatan.

BAB IX

PENUTUP

Pelayanan neonatologi yang dilaksanakan di rumah sakit hendaknya senantiasa sejalan dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran. Selain itu, dalam rangka menyongsong era globalisasi dan menghadapi persaingan bebas, maka pelayanan neonatologi rumah sakit juga harus dipersiapkan secara profesional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit selanjutnya akan meningkatkan nilai jualnya.

Pelayanan neonatologi merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit, dan merupakan salah satu pelayanan yang dapat diunggulkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan.

Buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan sistematis dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan neonatologi di rumah sakit yang tepat bagi pasien. Selain itu, pedoman ini bermanfaat bagi pengelola rumah sakit dalam mengimplimentasikan dan mengevaluasi kemajuan dan perkembangan pelayanan neonatologi

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Juni 2024
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS